

TEMA 16



EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE BIENETAR SOCIAL.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- El marco del Bienestar Social.	
1.1.- Concepto de Bienestar Social. 1.2.- Características del Bienestar Social. 1.3.- Evolución histórica del Bienestar Social. 1.4.- Tipologías de Política Social. 1.5.- Modelos de Política Social en la Unión Europea. 1.6.- Objetivos y elementos constitutivos del Bienestar Social en España.	
2.- Fundamentación Internacional de los Servicios Sociales.	
2.1.- Documentos de Naciones Unidas. 2.2.- Documentos de la Unión Europea.	
3.- Evolución y fundamentación legislativa del Sistema Público de Servicios Sociales en España.	
3.1.- Los Servicios Sociales en la Constitución Española. 3.2.- Los Servicios Sociales en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 3.3.- Las Leyes de Servicios Sociales de “primera generación”. 3.4.- Los Servicios Sociales en la Ley 7⁄1.985, Ley de Bases de Régimen Local. 3.5.- El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 3.6.- Desarrollo y consolidación del sistema público de Servicios Sociales. Leyes de Servicios Sociales de “segunda generación”. 3.7.- Hacia un nuevo modelo: Leyes de Servicios Sociales de “tercera generación”. 3.8.- El impacto de las Leyes Sectoriales. 3.9. Los cambios en la Ley 7⁄1.985. 3.10.- El Catálogo de Referencia de Servicios Sociales.	
4.- ¿HACIA UNA LEY ESTATAL DE SERVICIOS SOCIALES?	
4.1.- Antecedentes de la norma. 4.2.- Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 4.3.- Necesidad y oportunidad de su aprobación. 4.4.- Objetivos de la norma.	

0.- INTRODUCCIÓN.

Los servicios sociales en España **se implantaron tardíamente y fueron concebidos desde una perspectiva minimalista muy vinculada a la asistencia social** pero no como un pilar de la protección social. El marco constitucional español los reduce a la "**asistencia social**" que delega a la gestión autonómica. Las comunidades autónomas en general no vieren la necesidad de un desarrollo de los mismos en los años 70 y 80 del siglo pasado, pues no "hacían falta" cuando España tenía unas tasas de ocupación femenina inferiores al 40%. Los municipios, presionados por las demandas de los ciudadanos y siempre con limitada financiación, han ido dando repuestas a las necesidades sociales, no solamente en aquello que estaba en el campo de su competencia sino en aquellos campos en los que los problemas eran acuciantes y en los que otras administraciones no actuaban, en un contexto en el que tanto los recursos económicos como las competencias, no están distribuidos adecuadamente entre el nivel municipal y autonómico.

No cabe duda de que el desarrollo de los servicios sociales en España ha sido desordenado y ha obedecido a **lógicas incrementalistas**, desde las cuales se iban improvisando programas y respuestas que a veces funcionaban en paralelo, a veces se complementaban, pero por lo general con limitada consistencia integral. La provisión de los servicios desde el primer momento fue mixta, con mayor o menor participación de la iniciativa privada con y sin ánimo de lucro, dependiendo de sectores; así, por ejemplo, mientras que en el ámbito de la discapacidad hay presencia prácticamente exclusiva del Tercer Sector, en el ámbito de las personas mayores y la dependencia hay amplia presencia de las empresas mercantiles.

En los años ochenta, las **primeras leyes de servicios sociales** tuvieron escasa ambición, pero permitieron la universalización de una red incipiente de atención, aunque con limitada capacidad. Con la implantación del **sistema de dependencia** y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), a partir de mediados de la década del 2000 llegaron las "**Leyes de Tercera Generación**" que supusieron, al menos desde el punto de vista legislativo, un cambio de perspectiva al introducir determinados servicios como derechos subjetivos y otros como derechos condicionados, ampliando así la oferta y cobertura, al menos en el plano teórico.

Los avances normativos al nivel autonómico de las leyes de tercera generación no necesariamente se han traducido en desarrollos prácticos, bien por la falta de concreción posterior, la limitación de recursos, la ausencia de carteras de servicios, etc. La introducción del sistema de dependencia ha dado más relevancia al papel de los servicios sociales, pero a la vez les ha "saturado", por la ausencia de recursos que han aumentado escasamente durante los años de crisis, mientras que se agravaban las necesidades.

Más allá de la manifiesta falta de dotación presupuestaria, el fracaso del sistema de dependencia es reflejo de la dificultad de articular las competencias entre los distintos niveles la de administración pública (nacional, autonómico, local) y sus sectores (empleo, educación, sanidad, garantía de ingresos, vivienda).

Por otra parte, cada vez es más evidente la **ambigüedad del mandato de los servicios sociales**, por lo general excesivamente pretenciosos en sus declaraciones y objetivos, pero con **limitada dotación presupuestaria**, sometidos al corsé de la contención de gastos y la no-reposición de personal. Todo ello en un contexto en el que hay cada vez más **grupos de población "cronificados" en la exclusión múltiple, nuevas necesidades familiares, mayores demandas de apoyo a las personas mayores y dependientes por los cambios demográficos y en definitiva una ampliación de necesidades de las clases medias empobrecidas**. Se constata por otra parte una limitación en la aplicación efectiva de las carteras de servicios, que en muchos casos no están desarrolladas, dada la limitación de recursos y en ocasiones la discrecionalidad en el uso de los mismos.

Al carácter difuso del objeto y a la ambigüedad del mandato de los servicios sociales se añade la **ambigüedad sobre la responsabilidad de los distintos niveles administrativos en su ejecución**. La configuración de los niveles administrativos en España (Administración central, comunidades autónomas, diputaciones, municipios) hace que las competencias no siempre estén claras y sobre todo que no haya congruencia entre las competencias que cada nivel tiene y los medios económicos para financiarlas.

La **racionalización en el gasto**, como consecuencia de los excesivos endeudamientos, el aumento del déficit y las reglas del Memorando de Entendimiento impuestas a España por la Unión Europea tuvo repercusiones especialmente negativas en las administraciones locales. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) pretendía un recorte de competencias y de financiación a los gobiernos locales, y además establecía la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales. Más tarde, esta disposición transitoria fue declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional.

Estas restricciones presupuestarias se producen en un **contexto en el que la demanda de servicios sociales en España es mayor que en otros países europeos** debido a distintas razones: un tejido productivo de menor cualificación (industria no cualificada, construcción, servicios) que durante las crisis se traduce en un proceso más intenso de destrucción de empleo y precarización; el crecimiento de los precios de la vivienda en un contexto de mercado inmobiliario especulativo que limita el acceso a la cobertura de la necesidad de vivienda de una parte importante de la población e incrementa los procesos de exclusión residencial (endeudamientos, acogimientos, desahucios, infravivienda, sinhogarismo, etc.); una mayor debilidad del sistema de protección de desempleo de carácter contributivo y la ausencia de un sistema consistente de prestaciones de mínimos que en consecuencia no da cobertura a muchas situaciones de necesidad.

En resumen, podemos decir que los servicios sociales tienen atribuidas hoy de manera confusa, **funciones de asistencia social vinculadas a la provisión de prestaciones y ayudas y funciones de apoyo y acompañamiento en la promoción de las personas**. Estas funciones deberían de ser deslindadas dentro de la actual estructura institucional, aunque ambas permanezcan en los servicios sociales; parte de las prestaciones y ayudas deberían de ser gestionadas por otro ámbito, dado que no son propias de los servicios sociales; las que se desarrollen desde los servicios sociales, deberían de ser simplificadas y obedecer a requisitos claros verificables de forma administrativa; los recursos humanos deberían de reequilibrar su dedicación y concentrarse más en tareas de promoción y apoyo ligadas a los nuevos riesgos.

1.- EL MARCO DEL BIENESTAR SOCIAL.

El modelo de Bienestar Social en España se desarrolla –al igual que en Europa- a partir de los sistemas de Protección Social surgidos del pacto entre los sistemas de capital, trabajo y Estado, cuya expresión más significativa fueron los sistemas de la Seguridad Social. A partir de este modelo inicial, los sistemas de Bienestar Social iban a promover otras políticas de rentas, como pensiones, prestaciones por desempleo o prestaciones por minusvalías. Estos diferentes sistemas iban a garantizar unos niveles de renta en situaciones de vejez, invalidez o paro.

La España democrática se incorporar al proceso del bienestar con la **Constitución de 1.978**, cuando ya se habían consolidado en los foros internacionales los principios recogidos en diversos documentos internacionales –como el Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o en las Carta Social Europea-. Desde estos documentos se plantea una nueva filosofía en el Bienestar que pretende consolidar nuevos sistemas públicos para la cobertura de necesidades sociales básicas orientados hacia el **reconocimiento de derechos sociales universales** y la orientación hacia políticas que garanticen el **desarrollo social y humano.**

1.1.- CONCEPTO DE BIENESTAR SOCIAL.

Todas las sociedades han generado mecanismos propios para lograr la satisfacción de las necesidades. Para distinguir el Bienestar Social de otras formas de ayuda, hay que plantear dos premisas fundamentales:

1. El Bienestar Social es un concepto más amplio que los términos de "acción social" y "servicios sociales".
2. El Bienestar Social es una noción que excede al Estado de Bienestar.

Vamos a apuntar algunas ideas que diversos autores nos proponen como fundamentales respecto al concepto de Bienestar Social, para terminar, proponiendo la definición planteada por las Naciones Unidas.

√ **Manuel Moix** señala, en relación al origen etimológico del término "Welfare", como el **"tener un buen viaje"**. En este sentido, el Bienestar hace referencia –metafóricamente- al hecho de "viajar cómodamente" por el camino de la vida, el encontrarse bien, especialmente en relación con las condiciones de salud, prosperidad, felicidad …

√ **Merrill** aporta que el Bienestar Social es entendido como aquellos **juicios sociales** que se refieren a lo que es adecuado o importante en referencia al bien del individuo y del grupo.

√ **Garcés Ferrer** se refiere al Bienestar Social como un **valor final**, en el sentido de que trata de la forma con el hombre de entender su naturaleza y la manera de relacionarse con los demás. Esta creencia va a tener diferentes desarrollos históricos: caridad, beneficencia, políticas sociales …

√ En **Redondo de la Serna** el Bienestar Social establece como finalidad que todos los miembros de la sociedad deben disponer de los medios precisos para satisfacer las demandas comúnmente aceptadas como √necesidades. El Bienestar Social sería un valor general que orienta, bajo criterios de deseabilidad, la conducta colectiva de los ciudadanos de las sociedades contemporáneas, siendo a su vez una **meta legítima** de los grupos sociales, orientando la acción política administrativa.

√ Las **Naciones Unidas**, sintetizando, apuntan que "**el Bienestar Social es una actividad organizada, que se propone ayudar a una mutua adaptación de los individuos y su entorno social. Este objetivo es alcanzado mediante el uso de técnicas y métodos que están ideados para capacitar a los individuos, grupos y comunidades para hacer frente a sus necesidades y resolver problemas de la adaptación a un modelo cambiante de sociedad, y mediante la acción cooperadora para mejorar las condiciones económicas y sociales".**

√ En el contexto actual es fundamental referirnos al marco de actuación definido desde la ONU a partir de la **Agenda 2.030 para el Desarrollo Sostenible.** En esta Agenda se plantea un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que asume como el mayor desafío del mundo actual la erradicación de la pobreza en un contexto de desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 objetivos con 169 metas, que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Incluye, entre otros puntos, los objetivos de erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL BIENESTAR SOCIAL.

Manuel Moix Martínez plantea un conjunto de rasgos característicos del Bienestar Social que es importante señalar:

- El Bienestar Social de una persona no depende de lo que ella sienta o crea, sino de la concurrencia de determinados hechos objetivos. Los juicios referentes al Bienestar Social pertenecen a la esfera objetiva del conocimiento y no a la subjetiva del sentimiento. El Bienestar Social tiene que ser **objetivable.**
- El Bienestar tiene un claro **componente social o comunitario**, porque además de las necesidades individuales, el hombre siente necesidades relativas al establecimiento de un orden social compartido que conduzca a la consecución de aquellos supuestos y requisitos básicos para la felicidad que son comunes a todos los ciudadanos.
- El Bienestar implica una cierta **minimalidad**, referida a que en todas sus dimensiones hay que garantizar unos niveles básicos y esenciales.

En definitiva, estamos hablando de dos dimensiones básicas en relación al Bienestar Social:

- Una **dimensión interna**, que hace referencia a la vivencia de ciertos estados de la persona considerados como deseables y valiosos (seguridad, tranquilidad, desarrollo …).
- Una **dimensión externa**, que está relacionada con una serie de condicionantes ambientales, que permiten la posesión o acceso a recursos que posibilitan la satisfacción de ciertas necesidades o intereses.

El bienestar es, por tanto, una realidad compleja, que depende de múltiples factores, como son los ingresos individuales y familiares, la esperanza de vida o las posibilidades de acceso a la salud y la educación.

1.3.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BIENESTAR SOCIAL.

1.3.1.- Los orígenes del Estado de Bienestar.

En el Estado de Bienestar se van a sintetizar una serie de **reivindicaciones sociales, políticas y económicas** que se venían planteando desde finales del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX.

El desarrollo tecnológico e industrial trajo la consolidación definitiva del **capitalismo** como sistema económico. La lógica del beneficio económico conllevó una serie de **consecuencias sociales muy negativas**, ya que el desarrollo económico no iba acompañado de la igualdad social. La extensión y magnitud de las pésimas condiciones de vida de los trabajadores y la miseria de las grandes ciudades demuestran que el progreso tiene límites y, al amparo de la obra de Karl Marx, van a empezar a surgir los primeros movimientos obreros. El problema radica en que el Estado Moderno descansa en una contradicción fundamental: el Estado Moderno (y, en concreto, el Estado de Bienestar) trata de conciliar dos principios contrapuestos, la **libertad económica** del Liberalismo y la **igualdad social** del Socialismo.

Frente al modelo liberal clásico, inspirado en el "laissez faire", que hacía recaer sobre el mercado la solución de los problemas sociales, y frente a las propuestas socialistas que pretendían abolir la propiedad privada y socializar los medios de producción, una serie de reformadores sociales plantean un espacio intermedio que permitía el juego concertado de reformas dentro del sistema o "reformas legítimas". Así, va a surgir un **pacto "no firmado"** entre liberales y socialdemócratas que de esta forma tratan de superar las deficiencias del capitalismo no intervencionista –en el caso de los liberales-, abandonando –en el caso de los socialdemócratas- las vías revolucionarias del socialismo original e introduciendo reformas paulatinas dentro del sistema político.

1.3.2.- Etapas claves en el desarrollo histórico del Estado de Bienestar.

Podemos concretar en el desarrollo histórico del Estado de Bienestar cinco etapas fundamentales:

1.- Una primera fase se inicia en el **último tercio del siglo XIX** con la legislación alemana y se prolonga hasta 1.914. Esta etapa se caracteriza por los **Seguros Sociales aprobados por el canciller Bismarck.** Este hecho es considerado como el primer paso en la construcción del Estado de Bienestar.

2.- La segunda fase queda ubicada entre las dos Guerras Mundiales. Se produce un estancamiento.

3.- La tercera se inicia tras la Segunda Guerra Mundial. Las reformas se hacen **más amplias y extensivas a otros conjuntos de la población.** La pieza clave sigue siendo la Seguridad Social, pero gradualmente va aumentando el peso de la educación, de la sanidad, del empleo, de la vivienda …

A partir de este instante la mayor parte de los países desarrollados capitalistas van a adoptar la doctrina recogida en el **Informe Beveridge** (1.942) [1] y los planteamientos de la **política económica keynesiana.**

El **modelo keynesiano** sobre el que se fundamenta el Estado de Bienestar, y que se desarrolla a partir de la II Guerra Mundial, otorga al estado una **función interventora**, que se podría concretar en dos ámbitos:

Política económica.	El estado se convierte en un elemento dinamizador del sistema económico, cuyo objetivo prioritario es el mantenimiento de la actividad, impulsando la producción, orientando la política de gasto y de inversión, y corrigiendo los desajustes que se van produciendo. El estado adquiere la función de reactivar la economía, especialmente en los momentos en los que el crecimiento no está garantizado, debido a las fluctuaciones a las que se encuentra sometido el mercado.
Política social.	A fin de conseguir: a.- Una **distribución de la renta**, mediante la financiación de un amplio sistema de servicios sociales de carácter asistencial y de un nuevo sistema de seguridad social, articulado en torno a un principio de reparto, que ha ido sustituyendo a los seguros privados. b.- La **promoción del pleno empleo**, estableciendo una política de concertación social que garantice elevados salarios y otras ventajas laborales.

Ambas políticas, la económica y la social, requieren una **política fiscal,** basada en un sistema progresivo que permita generar recursos suficientes para financiar la política económica y social.

La **intervención del Estado,** como regulador de la vida económica, se justifica por tres razones:

- Para hacer compatible el modo de **producción capitalista** –en la que prevalece la lógica del beneficio- y el **sistema democrático** –en el que prevalece la lógica de la participación y de la redistribución-.
- Para fomentar la **actividad económica** y lograr la consecución del **pleno empleo**.
- Para **evitar el conflicto social** –tan intenso en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial-, alejando los peligros revolucionarios, y proporcionando unas cuotas de bienestar y seguridad para todos los sectores sociales.

[1] El **Informe Beveridge** ("Report Beveridge") trataba de afrontar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y suavizar las desigualdades sociales a través de una doble redistribución de la renta, actuando sobre la Seguridad Social y sobre las subvenciones estatales.

Tras la Gran Depresión, el "New Deal" y la derrota de los fascismos europeos, con la implantación del Estado de Bienestar, se producen importantes cambios en el régimen de la protección social. El ámbito económico y el espacio social dejan de estar en contradicción, y pasan a funcionar de forma orquestada bajo el control del gobierno. El nuevo Estado Keynesiano, mediante mecanismos de redistribución y asistencia, trata de desarrollar una sociedad sin fracturas importantes ni grandes desequilibrios.

4.- En esta cuarta fase se va a **consolidar** el proceso apuntado en los párrafos anteriores. Abarca desde 1.950 hasta la década de los setenta. En Europa Occidental va a coincidir con un proceso de desarrollo económico sin precedentes y con tasas de empleo cercanas el pleno empleo. Las notas más destacadas son:

- **Universalización del sistema de la Seguridad Social.**
- **Universalización de los Servicios Sociales.**
- **Coordinación e integración de los sistemas precedentes.**

5.- Esta fase se caracteriza por la **crisis del Estado de Bienestar**. En la primera mitad de los años 70 la crisis del petróleo provocó una crisis económica a nivel mundial con consecuencias económicas muy graves en relación a la credibilidad del Estado de Bienestar:

- Aumento del nivel de desempleo.
- Descenso de las inversiones.
- Freno del crecimiento económico …

Para algunos autores el Estado de Bienestar es responsable de esta crisis, sobre todo debido al excesivo gasto público realizado. La **posición neoconservadora** afirmaba que el Estado de Bienestar genera más daños que soluciones, por lo que se propone un repliegue de la intervención estatal. Los subsidios de desempleo, las prestaciones sociales … son ineficaces, generan despilfarro económico y dependencia de sectores de la población de las ayudas estatales.

Desde **los planteamientos marxistas** se va a plantear también una crítica importante al Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar ha supuesto la incorporación del proletariado al sistema capitalista a través de la democracia política. La clase obrera pierde así su potencial revolucionario, debido a su aburguesamiento y desmovilización. De esta forma el Estado ha logrado armonizar los intereses de la economía capitalista y los procesos de exclusión que ella misma desencadena. Los gastos sociales fueron el precio que el Estado pagó para obtener el consenso político y su legitimación.

La **perspectiva liberal demócrata** propone la vuelta a la neutralidad del Estado. El Estado es necesario para crear, definir y reforzar un marco regulador en el que operen las diferentes fuerzas económicas, políticas y sociales, pero se convierte en un instrumento pasivo. La intervención social del Estado es mínima, tratando fundamentalmente de asegurar la paz social ante las propias contradicciones del sistema. El Estado se legitima interviniendo para atender a los colectivos más desfavorecidos, pero sin cuestionar ni cambiar las bases de la economía de mercado ni la estructura social.

La **posición social demócrata** plantea que el Estado puede ejercer un control indirecto sobre el mercado mediante políticas sociales, fiscales … Plantean que la continuidad del Estado de Bienestar, mediante el desarrollo de los servicios sociales colectivos y la tendencia a la igualdad de la renta (a través de una fiscalidad progresiva) podría terminar con las desigualdades sociales.

6.- El **crack financiero del año 2.008** ha situado de nuevo en primer plano el debate sobre las posibilidades del propio Estado de Bienestar. La situación de desempleo masivo que afecta a las economías de todo el mundo hace que los indicadores de pobreza infantil o de familias que no tienen medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas suponga un claro retroceso en los derechos sociales que se han ido construyendo progresivamente.

1.4.- TIPOLOGÍAS DE POLÍTICA SOCIAL.

Podemos diferenciar varias tipologías de política social (algunos autores plantean estas categorías también como categorías del bienestar social).

P.S. como caridad.	Fue la primera perspectiva de intervención en términos históricos. Los grandes poderes públicos (no solo gobiernos, también la Iglesia) atienden a los individuos sumidos en la pobreza y la indigencia desde planteamientos ético-políticos. Es un planteamiento humanitario, religioso … pero alejado de la consideración de ciudadanía. La Política Social es un remedio puntual, no se consideran cuestiones tales como las estructuras económicas, sociales o políticas.
P.S. como garantía del control social.	El objetivo final es el control social. Trata de asegurar de forma regulada las condiciones de vida de ciertos estratos de la población para mantener el orden vigente y la paz social. Trata de estabilizar la relación entre los ámbitos productivos e improductivos de la sociedad sin poner en peligro la estabilidad del sistema. La Política Social satisface las necesidades mínimas de estratos de la población susceptibles de generar revueltas sociales. El componente ético del modelo anterior es sustituido por un componente pragmático de claras connotaciones clasistas.
P.S. como mecanismo de reproducción social.	Es una interpretación de origen marxista: la Política Social busca reproducir las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora, para evitar sus procesos de emancipación.
P.S. como realización del derecho social de la ciudadanía.	La PS es la realización de los derechos sociales, civiles, económicos, políticos … de la ciudadanía. Es un planteamiento realizado desde una perspectiva jurídica-política que implica a todas las fuerzas y agentes sociales. La PS se dirige a la totalidad de la sociedad.

Teniendo en cuenta los **diseños administrativos**, podemos diferenciar entre:

Modelo residual.	Parte del supuesto de que existen dos canales que permiten satisfacer las necesidades individuales: el mercado privado y la familia. Las instituciones sociales solo deben intervenir cuando fallan alguno de estos dos canales. Además, esta intervención es solo temporal.
Modelo adquisitivo-ejecutivo.	Las necesidades sociales deben ser satisfechas desde la base del mérito o de la capacidad ejecutiva/productiva del individuo. Las instituciones sociales son solo auxiliares de las instituciones económicas, propiciando el bienestar solo en la medida en que esto contribuye a la riqueza común.
Modelo institucional-redistributivo.	El bienestar social es un valor fundamental que debe ser asegurado de tal modo que permita cubrir las situaciones de necesidad al margen del mercado. Este modelo persigue el gran objetivo de la igualdad social e incorpora sistemas de redistribución específicos, que buscan compensar a aquellos sujetos que por diversas razones han quedado fuera de las condiciones de bienestar.
Modelo total.	Sería el modelo más parecido al "socialismo real": es un modelo de planificación total. Todos los criterios de asignación de la riqueza se basan en una programación estatal para atender unas necesidades reconocidas y socialmente legitimadas.

1.5.- MODELOS DE POLÍTICA SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA.

Es ampliamente reconocida la diversidad de características y circunstancias históricas, económicas y políticas de los Estados ha dado lugar a la aparición **de distintos modelos sociales en Europa en función de las políticas y acciones llevadas a cabo por el Estado en el ámbito del Estado de Bienestar.**

Partiendo de esta consideración, son múltiples las investigaciones realizadas al respecto e igualmente existe una gran diversidad de opiniones sobre los modelos de Servicios Sociales existentes y las características de cada uno de ellos. No obstante, destacan las clasificaciones de los modelos de bienestar que realizan dos autores, **Gosta Esping-Andersen (1990) y André Sapir (2005)**; siendo ambas ampliamente reconocidas y profundamente estudiadas por muchos autores.

Partiendo en primer lugar del estudio realizado por **Esping-Andersen**, nos encontramos con que este autor estableció básicamente tres modelos de Estado de Bienestar:

Modelo liberal anglosajón.	En este modelo se incluye a **Gran Bretaña e Irlanda**. Su origen se remonta a la economía británica del siglo XIX. La característica más significativa es que el Estado cubre los riesgos establecidos de una manera restrictiva, es decir, los sujetos tienen derecho a los servicios asistenciales únicamente después de comprobar los medios de vida e ingresos del beneficiario y verificar que existe una verdadera necesidad de asistencia. En este caso el Estado tiene una **intervención mínima** garantizando una protección social muy elemental, favoreciendo el desarrollo de seguros privados.
Modelo conservador.	Los países que se incluyen en este modelo son **Alemania, Austria, Bélgica, Francia e Italia**. Esping sugiere que surge a partir de las reformas de seguridad social emprendidas en el siglo XIX en Alemania. En él se parte del **principio de subsidiariedad**, y por tanto el Estado interviene cuando dejan de ser efectivas las instituciones más cercanas al individuo, como por ejemplo la familia. Se caracteriza, por tanto, porque presenta un sistema de seguridad social en el que los servicios sólo satisfacen las necesidades de los sectores más desfavorecidos y marginados dentro de la estructura social. Otro aspecto relevante es que la familia desempeña un papel relevante otorgándole la función de ser responsable del bienestar de sus miembros.
Modelo socialdemócrata o nórdico.	Este modelo tiene sus orígenes en el siglo XIX y se desarrolla en los países nórdicos de **Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia**. Se caracteriza por tres aspectos fundamentales: en primer lugar, se basa en el **principio de universalidad**, lo que supone el reconocimiento de los derechos civiles a toda la población de forma sistemática otorgando de esta manera un alto nivel de protección social. En segundo lugar, reconoce la **igualdad de derechos** entre sus ciudadanos a los que asiste con niveles de subsidio generosos y con una cobertura ante situaciones de riesgo de carácter global, lo que supone que el Estado cubre todos los riesgos. Por último, **los servicios de bienestar privados tienen un carácter residual** ya que lo que se pretende es que los individuos tengan una dependencia de los mercados mínima. Otra característica significativa de este modelo es que **el Estado tiene un papel altamente intervencionista** y defiende la política del pleno empleo. El gasto social es muy alto y se establecen estrictos controles sobre dicho gasto. Finalmente, es significativo en este modelo la desmercantilización que se persigue del bienestar y el hecho de que aleja a la institución de la familia de la responsabilidad de la protección en caso de la necesidad de asistencia ante una situación de riesgo.

Si bien Gosta Esping- Andersen distinguía tres modelos de Estado de Bienestar, el autor **André Sapir** (2005) defendía la existencia de cuatro modelos: **el modelo nórdico, el modelo continental, el modelo anglosajón y el modelo mediterráneo**. Vamos a describir a continuación los aspectos más relevantes de cada uno de ellos.

El modelo nórdico.	Se aplica en **Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia, Suecia y Países Bajos**. Las principales características del modelo nórdico son el **universalismo, la financiación por impuestos, la provisión pública de transferencias y servicios y el énfasis en los servicios sociales personales.** Por ello, tiene el nivel más alto de protección social y permite el acceso a las prestaciones sociales de una forma más generalizada y con menos condiciones. También presenta una elevada recaudación fiscal basada en los impuestos y contribuciones sociales de los empleadores y de los empleados. Por lo que respecta al mercado de trabajo, en este modelo son importantes los gastos destinados a impulsar políticas activas que faciliten una reinserción rápida de los desempleados en el mercado de trabajo. Se caracteriza también por la existencia de un gran número de empleados públicos. Existe una elevada afiliación a los sindicatos por lo que éstos tienen un importante poder de decisión; esto evita que exista una gran dispersión salarial lo que garantiza una distribución más equitativa de la renta.
El modelo continental.	Se lleva a cabo en **Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo**. Este modelo se basa en el **principio contributivo** lo que supone que los trabajadores y los empleadores cotizan de forma obligatoria para crear unos fondos que cubran situaciones de riesgo. Se establece un sistema de subsidios parcialmente no condicionado a la empleabilidad. Se diferencia del modelo nórdico en que una mayor proporción de los gastos se destinan a las pensiones. Debe tenerse en cuenta el progresivo envejecimiento de la población en estos países desde finales de los años 1970 y disminución de la tasa de natalidad. Los sindicatos presentan una afiliación muy baja, sin embargo tienen un gran poder de decisión en las negociaciones colectivas.
El modelo anglosajón.	Se desarrolla en **Irlanda y Gran Bretaña** y se caracteriza porque presenta unas medidas preventivas menores que otros modelos y **el tipo de asistencia social es la denominada de último recurso**. Esto significa que las ayudas sociales son de carácter básico o residual, ya que se presupone que será el individuo el que haga el esfuerzo para mejorar su situación. Este modelo no ve la pobreza como un problema estructural de la sociedad sino como un problema del individuo. Los subsidios se dirigen fundamentalmente hacia la población en edad de trabajar y los jóvenes y en menor medida hacia las pensiones. El acceso a los subsidios está condicionado en mayor medida a la empleabilidad, es decir, se tiene en cuenta si la persona ha trabajado anteriormente o está buscando trabajo en ese momento. En cuanto al mercado de trabajo, en este modelo son bastante importantes los gastos en políticas activas de promoción de empleo, educación y cualificación de los trabajadores. Los sindicatos tienen un menor poder de participación en las decisiones gubernamentales o patronales por lo que en estos países se da una mayor dispersión salarial, existiendo un mayor número de empleos con salarios bajos.

	El modelo anglosajón se considera uno de los más eficientes, después del modelo nórdico, en lo que se refiere a la reducción de la pobreza y a la promoción de incentivos para el empleo. Consigue mejores resultados en materia de empleo y es más sostenible financieramente a largo plazo.
El modelo mediterráneo.	Aplican este modelo **Grecia, Italia, Portugal y España**, países que han desarrollado un Estado de Bienestar más tarde, concretamente entre los años setenta y ochenta. Es un modelo social con menores gastos que el resto de las modelos y fuertemente **basado en las pensiones y tiene unos gastos de asistencia social muy bajos**. El acceso a las prestaciones está muy condicionado. Otro aspecto importante es que se considera a la **familia** como un instrumento clave en el bienestar social de sus ciudadanos quedando en un segundo plano la intervención pública. El principal rasgo del mercado de trabajo es la fuerte protección del empleo (no confundir con la protección del trabajador o subsidio de desempleo) y la existencia de la jubilación anticipada como sistema de mejora del empleo. Los sindicatos desempeñan un papel relevante en la negociación colectiva, por lo tanto, se produce una menor dispersión en los salarios que en el modelo anglosajón.

Al esquema clásico propuesto por Sapir habría que añadir dos nuevos modelos de Bienestar adicionales, surgidos tras la incorporación de los países de la **antigua Europa del Este**.

El modelo de la Europa Central y del Este.	Tras la caída de la URSS, los países soviéticos mantuvieron unos regímenes de Estados del bienestar relativamente amplios. A pesar de las amplias diferencias culturales, sociales y económicas, los países comprendidos en este modelo comparten algunos rasgos estructurales en relación a sus políticas de bienestar. En primer lugar, se caracterizan por una presión fiscal más baja que impide aumentar de manera creciente y sostenida el gasto público social. En segundo lugar, la economía sumergida es importante en estos países. Por otro lado, la mayoría de los países de la Europa Central y del Este acometieron reformas estructurales del sistema de pensiones y adoptaron, durante la primera década del presente siglo, sistemas mixtos de pensiones con un pilar obligatorio de capitalización privada. Podemos definir su modelo de Estado de bienestar como un modelo mixto entre políticas residualistas de bienestar, programas de mantenimiento de rentas y un cierto estatismo. La evolución de la desigualdad es muy dispar en estos países. Ello se debe, en parte, a que no tienen un modelo homogéneo de Estado del bienestar. Mientras en Bulgaria, República Checa, Polonia y Rumanía la desigualdad muestra una tendencia decreciente, en Hungría, Eslovaquia, Croacia y Eslovenia la tendencia es la contraria.
El modelo báltico.	Estos países comparten una serie de características peculiares que se desprenden del régimen post-comunista. Tienen una serie de prestaciones universales con amplitud en los beneficios sociales, sin embargo, existe una escasa conciencia fiscal acerca de la necesidad de recaudar los impuestos necesarios para financiar las prestaciones y servicios públicos. Podríamos decir que el modelo báltico de bienestar es un híbrido entre el sistema liberal anglosajón y el sistema continental europeo. No obstante, la satisfacción de las necesidades sociales depende, en gran parte, del mercado y de los propios agentes privados. Por otro lado, han acometido reformas estructurales del sistema de pensiones con modelos mixtos públicos y de capitalización privada.

1.6.- OBJETIVOS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL BIENESTAR SOCIAL EN ESPAÑA.

En España, ya en el **siglo XIX**, coexisten la beneficencia y la asistencia social. Como consecuencia de las Cortes de Cádiz, se aprueba la Ley de Beneficencia de 1822 y, posteriormente, la de 1849. Pero en la segunda mitad del XIX, se deja notar el influjo del movimiento obrero, el socialismo, las medidas bismarkianas de previsión social, el socialismo fabiano en Inglaterra, la aparición de los partidos políticos, los movimientos sindicales y la cuestión social va a convertirse en asunto central de este siglo. En este contexto, se acelera el **intervencionismo estatal en materia social**.

En España la prueba de ello es la creación de la **Comisión de Reformas Sociales en 1.883**. La Comisión tenía por objeto el estudio de todas las cuestiones relativas a los problemas sociales. Como resultado de su labor, se van a promulgar numerosas disposiciones en materia social. La Comisión fue el germen de la legislación social y asistencial posterior.

Ya a comienzos del siglo XX, se creará el **Instituto de Reformas Sociales**, en **1903**, y el **Instituto Nacional de Previsión**. Durante la primera mitad de este siglo, comienzan los Seguros Sociales y la posterior aparición de la Seguridad Social como sistema público organizado de protección social. Por tanto, coexisten en España en esta época, la Beneficencia, la asistencia social, los Seguros Sociales y la Seguridad Social.

Nuestro marco constitucional establece la igualdad de derechos políticos, sociales, culturales … en base a la **ciudadanía**. Este modelo de bienestar se sustenta en los principios de universalidad de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades, la cooperación y la corresponsabilidad social, el desarrollo social y humano, etc., que quedan recogidos en las leyes específicas de protección social en España y en las Comunidades Autónomas –educación, sanidad, pensiones, servicios sociales …-.

Podemos destacar los siguientes **objetivos** en relación al bienestar social:

- **Garantizar la atención de necesidades básicas al conjunto de la población** mediante la puesta en marcha del principio de igualdad de derechos de todos los ciudadanos, haciendo efectivo este principio mediante la **universalización de las prestaciones básicas** que han de ofertar los Sistemas Públicos de Sanidad, Educación, Pensiones, Servicios Sociales, Desempleo …
- **Defender la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos** de forma normalizada y a la promoción y desarrollo integral de las personas y grupos sociales más desfavorecidos, garantizando el respeto a su identidad diferencial y las medidas adecuadas de acción positiva mediante Planes y Programas Integrales.
- **Asegurar un tratamiento integral de las personas y los grupos** ante sus necesidades sociales, estableciendo mecanismos de cooperación interdepartamental que den globalidad y eficacia a la política social.
- **Prevenir la marginación y la pobreza** con Planes de Desarrollo Humano y Social y de Lucha contra la Exclusión, fomentando la planificación local integrada desde los propios recursos humanos y socioeconómicos de la comunidad para la integración y cohesión social.
- **Promover la solidaridad** entre instituciones y ciudadanos y entre los propios ciudadanos a través de la promoción de la responsabilidad social ante las necesidades humanas, mediante el reconocimiento y apoyo institucional a las familias y las organizaciones sociales, mediante el fomento de la participación ciudadana y el voluntariado social.
- **Promover la calidad de vida** potenciando el papel de los profesionales y la participación de los usuarios, garantizando el control de la calidad de los servicios públicos y la correcta aplicación de los derechos humanos.

Estos objetivos marcan las tendencias sociales fundamentales en relación a las Políticas Sociales, implantando Sistemas Públicos que garanticen el derecho social a la cobertura de las necesidades básicas, la puesta en marcha de Planes Integrales para la igualdad de oportunidades de diferentes colectivos, la potenciación de Planes de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social o la promoción de Políticas de Cooperación Social con el objetivo de potenciar la corresponsabilidad política y social ante las necesidades sociales.

En el marco normativo del Estado y de las Comunidades Autónomas, el Bienestar Social se refiere a la Política Social en que se integran una serie de Sistemas de Protección Social y Servicios Públicos, que han de garantizar los derechos universales que la Constitución y los Estatutos de Autonomía reconocen a todos los ciudadanos. El Bienestar Social ha de hacer real y efectiva la **garantía de los derechos sociales básicos** para toda la ciudadanía en materia de **educación, sanidad, pensiones, desempleo y servicios sociales.**

Es fundamental primar en el marco del desarrollo de estos Sistemas de Protección medidas preventivas, de participación social y de calidad en la prestación de los servicios, procediendo a la máxima descentralización en el marco de las competencias locales y autonómicas, articulando la cooperación entre Administraciones mediante Planes Concertados que garanticen la adecuada planificación y redistribución de recursos.

2.- FUNDAMENTACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

Es importante acercarnos a la **fundamentación internacional** en el ámbito de los Servicios Sociales, ya que implican la adhesión por parte de nuestro país a documentos y Tratados que contribuyen al bienestar y desarrollo de la ciudadanía.

2.1.- DOCUMENTOS DE NACIONES UNIDAS.

2.1.1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A, el **10 de diciembre de 1.948 en París**, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos.

En su **artículo 25** reconoce:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

2.1.2.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2.030.

La Estrategia de Objetivos de Desarrollo Sostenible fue aprobada por las Naciones Unidades el **25 de septiembre de 2.015**: una Agenda de carácter universal e integral estructurada en torno a **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas.**

Los ODS suponen una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa que pretender marcar la hoja de ruta de la comunidad internacional para **lograr el crecimiento económico, la justicia social y la protección del medio ambiente** en un mundo en el que la pobreza, la desigualdad y la degradación ecológica son la realidad cotidiana de millones de personas.

Su puesta en práctica implica el desarrollo de **5 dimensiones fundamentales de los ODS: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.**

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.	
OD1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo.	**OD10.** Reducir la desigualdad entre los países y dentro de ellos.
OD2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	**OD11.** Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
OD3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades.	**OD12.** Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
OD4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas.	**OD13.** Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
OD5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	**OD14.** Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
OD6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.	**OD15.** Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
OD7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.	**OD16.** Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones efectivas e inclusivas que rindan cuentas.
OD8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	**OD17.** Alianzas para lograr los Objetivos (revitalizar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible).
OD9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación	

2.2.- DOCUMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

La Unión Europea constituye una **entidad supranacional** que, mediante estrategias políticas generales, delimita cómo deben ser las políticas nacionales de sus Estados miembros. La **Política Social** de la UE se ha desarrollado desde el **Tratado de Roma** de 1.957, hasta la actualidad, de un modo más o menos intenso en torno a una serie de factores: regulación del mercado y de las condiciones de trabajo, establecimiento de igualdad de oportunidades, seguridad y salud laboral, movilidad laboral, protección social e inclusión social.

Aunque la UE ha conseguido una eficaz configuración de instituciones económicas, la consecución de una política social aún está en marcha, en la medida en que aparecen nuevos riesgos sociales que plantean nuevos retos al **modelo social europeo.**

Desde comienzos del siglo XXI se ha generalizado el uso del término **inclusión** en la política social europea y se ha convertido en habitual en el vocabulario cotidiano en su desarrollo, valoración y gestión. Este término surge en el propio proceso político, sin referencias teóricas claras, pero ha ocupado un espacio central en las transformaciones de la política social en la primera década del siglo XXI.

2.2.1.- La Carta Social Europea.

La **Carta Social Europea** de 1961 contenía 19 derechos laborales y **sociales**, como el derecho al trabajo, a condiciones laborales justas y seguras, a una remuneración suficiente, a la negociación colectiva, a la formación profesional, a la seguridad y asistencia **sociales** o a la salud.

"Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las Partes se comprometen:

1.- A fomentar u organizar servicios que, utilizando los métodos de un servicio social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, así como a su adaptación al medio o entorno social;

2.- A estimular la participación de los individuos y de las organizaciones benéficas o de otra clase en la creación y mantenimiento de tales servicios **(art. 14 de la Carta Social Europea. Se firmo en 1.961 y se revisó en 1.996)".**

2.2.2- El Pilar Social Europeo.

En **abril de 2017**, con la intención de apoyar la convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo en unos mercados laborales cada vez más flexibles, la Comisión presentó el pilar europeo de derechos sociales. En noviembre de 2017, las tres principales instituciones de la Unión expresaron su compromiso con este pilar en una Proclamación conjunta.

El **pilar europeo de derechos sociales** consiste en **dar a los ciudadanos unos derechos sociales nuevos y más efectivos**. Se basa en veinte principios estructurados en tres categorías:

- Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo.
- Condiciones de trabajo justas.
- Protección e inclusión social.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO.	
1.-	Educación, formación y aprendizaje permanente
2.-	Igualdad de sexos
3.-	Igualdad de oportunidades
4.-	Apoyo activo para el empleo
CONDICIONES DE TRABAJO JUSTAS.	
5.-	Empleo seguro y adaptable
6.-	Salarios
7.-	Información sobre las condiciones de trabajo y la protección en caso de despido

8.-	Diálogo social y participación de los trabajadores
9.-	Equilibrio entre vida profesional y vida privada
10.-	Entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos
PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL.	
11.-	Asistencia y apoyo a los niños
12.-	Protección social
13.-	Prestaciones por desempleo
14.-	Renta mínima
15.-	Pensiones y prestaciones de vejez
16.-	Sanidad
17.-	Inclusión de las personas con discapacidad
18.-	Cuidados de larga duración
19.-	Vivienda y asistencia para las personas sin hogar
20.-	Acceso a los servicios esenciales

3.- EVOLUCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA.

Tradicionalmente, en España, la preocupación pública por la atención social ha estado ligada a medidas contra la miseria, su tratamiento o control. La Administración Pública actuaba de forma subsidiaria y, fundamentalmente, mediante el ingreso en instituciones cerradas, lo que dio lugar al desarrollo de servicios especializados para determinados grupos de personas, si bien con presupuestos limitados y con una atención meramente asistencial.

Desde 1.975 aproximadamente, comienza en nuestro país un proceso de cambio que tiene importantes repercusiones en los Servicios Sociales. Este proceso es fundamental para la construcción del Estado de Bienestar en nuestro país.

Un autor clásico, **Habermas**, señala las tres características fundamentales del Estado de Bienestar. Estas son:

1.- Intervención del Estado en la economía.	En el Estado de Bienestar las funciones económicas clásicas que realizaba el mercado (guiada por la "mano invisible") las realiza el Estado. La intervención estatal es diversa, pero fundamentalmente trata de asegurar: • El desarrollo y mejora de las infraestructuras materiales. • El control de las crisis económicas cíclicas. • El fomento del consumo de masas. • El control del mercado. • La paz social.
2.- Democracia de masas.	Es la coexistencia entre el capitalismo keynesiano y la democracia formal. La principal fuente de legitimación del Estado es la democracia formal, que postula como principio básico la participación universal en el proceso de formación de la voluntad política.
3.- Estado Social.	Este rasgo plantea la responsabilidad estatal en el desarrollo del bienestar social. El Estado pone en marcha políticas sociales, tanto para la población en general, como para la solución de problemas sectoriales.

Otros autores plantean que son necesarios tres factores para el desarrollo del Estado de Bienestar:

- Desde una perspectiva económica, se tiene que haber producido el paso de las economías industriales a las **economías de servicios.**
- Desde una perspectiva de clases sociales, se tiene que haber consolidado el predominio de la **clase media.**
- Desde una perspectiva política, el régimen desde el que se puede iniciar el Estado de Bienestar es la **democracia.**

En ambos esquemas, la realidad española no cumple los requisitos para el nacimiento del Estado de Bienestar hasta mediados de los años 70, cuando tras la muerte de Franco se inicia el proceso democrático en nuestro país. Desde los años 60 –década del desarrollo económico español- teníamos una economía en la que empieza a predominar el sector de los servicios (gracias al turismo) y se empieza a ampliar la clase media, pero no había un régimen democrático. Todo esto significa que el proceso de desarrollo de Políticas Sociales se inicia en nuestro país más tardíamente que en otros países del entorno.

Tras la muerte de Franco se inician en España una serie de transformaciones con importantes repercusiones en la esfera de la acción social. Las respuestas públicas existentes en aquel momento para las personas no incluidas en el campo de actuación de la Seguridad Social eran, por una parte, la asistencia social de ámbito estatal y, por otra, la beneficencia en el ámbito de la administración local.

Junto a ellas existían, de forma dispersa, otro tipo de actuaciones públicas dirigidas a determinados colectivos como las realizadas por el Patronato de Protección a la Mujer, Patronato de Protección a Menores, el Fondo de Asistencia Social (FONAS) –pensiones asistenciales a enfermos y ancianos- … En definitiva, no existía en España un sistema público integrado y coordinado de Servicios Sociales.

A partir de 1.978 se observa ya el intento de poner en marcha un proyecto de sistema público de Servicios Sociales, siguiendo la tendencia de los países europeos más avanzados:

- Descentralización y regionalización de los servicios.
- Intensificación de la cooperación entre los sectores público y privado.
- Enfoque más preventivo que asistencial por parte de los Servicios Sociales.
- Desarrollo de la ayuda mutua en el seno de la comunidad.

Un hecho importante en la gestación de estos cambios es la **consulta a expertos internacionales realizada en Madrid en enero de 1.978.** Este análisis señala los siguientes elementos en relación a la **situación de los Servicios Sociales en España:**

- Que había políticas diversas y paralelas para las diferentes necesidades y sectores de población.
- Que existen diversos organismos especializados, sin conexión entre los diferentes departamentos y sin ningún sentido de globalización.
- Predominio de la función asistencial y reparadora.
- La iniciativa privada –frecuentemente de la Iglesia Católica- había ido supliendo al Estado, otras veces se habían duplicado los servicios por falta de coordinación.
- Existencia de una fuerte centralización.
- Superprotección de algunos sectores de población, por duplicidad de servicios. Otros sectores no obtenían la protección necesaria, produciéndose de esta forma mal uso de los recursos y prestaciones desiguales para diversos grupos de población.
- Mínima participación de la población en los servicios.

Estas consideraciones pusieron de manifiesto la ineficacia de las respuestas existentes –en su mayoría benéficas y asistenciales- y, en definitiva, la inexistencia de un sistema público eficaz para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Existe en esta época un acuerdo bastante generalizado acerca de los efectos negativos y la gran dependencia que provocan las respuestas tradicionales, como la institucionalización y las prestaciones económicas. De forma paulatina, comienzan algunos ayuntamientos y diputaciones a emprender iniciativas en un intento por modificar y superar los esquemas tradicionales de orientación benéfico-asistencial. Esto se lleva a cabo con muchas dificultades al mantenerse en vigor la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1.955 y predominar la idea tradicional de ofrecer el servicio público benéfico al "pobre" y no como un derecho individual.

3.1.- LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Para algunos autores. aunque la **Constitución** se pronuncia acerca de distintos temas relacionados con la política social, en realidad no hay en ella una regulación clara de los Servicios Sociales. Otros autores destacan que sí se produce una constitucionalización implícita de la ayuda social y que, al implicar la intervención del Estado, se requiere que éste proporcione ciertas prestaciones, justificando así la oferta de servicios sociales públicos.

La ausencia del tratamiento global de la Asistencia Social y de los Servicios Sociales no implica una ausencia del compromiso social en la C.E. Son varios los argumentos que pueden señalar la presencia de una **base político-institucional** para el establecimiento de un sistema público de Servicios Sociales.

Por tanto, a pesar de estas limitaciones, podemos afirmar que la configuración del actual sistema público de Servicios Sociales surgió de la Constitución Española, que otorgara estas competencias a las comunidades autónomas.

La referencia explícita en la Constitución Española de 1.978 en materia de servicios sociales se limita a la **asistencia social** (art. 148.1.20). Se trata de un concepto vago, impreciso que parece referirse a un conjunto de prestaciones dirigido a un colectivos vulnerables o desfavorecidos.

Sin embargo, la CE impone a los poderes públicos determinadas obligaciones a las que sólo se les puede dar respuesta mediante un sistema de servicios sociales. La declaración del **art. 1.1.** de que España es un Estado Social se concreta esencialmente en el mandato genérico contenido en el **art. 9.2.** y en diversas obligaciones específicas agrupadas en el **Capítulo III del Título I.**

El Estado Social.	La utilización de la expresión "**Estado Social**" (**art. 1**) plantea un doble significado. Por una parte, expresa el reconocimiento de la pluralidad de entidades, asociaciones y organizaciones existentes en nuestra sociedad. Su segundo significado hace referencia a la importancia de "lo social" en la configuración de nuestro país. La concepción de Estado Social implica una acción positiva de la Administración para que la igualdad social sea efectiva. La fórmula constitucional se inspira en la corriente socialdemócrata, que estaba en el fondo de la aparición de los estados de bienestar europeos. La búsqueda de la igualdad se va a realizar dentro del marco democrático liberal, de tal forma que igualdad y libertad tratan de conjugarse en un equilibrio difícil. En definitiva, sin educación, sin salud, sin vivienda, sin trabajo... la libertad carece de las condiciones para ser real. Desde este punto de vista, un elemento fundamental del Estado Social es la **actividad intervencionista**. De ahí que también se habla de un Estado de servicios, un Estado de Bienestar, un Estado benefactor, que va a dar lugar al derecho a las diferentes prestaciones.
La plena participación ...	Este compromiso lo podemos encontrar en el **artículo 9.2**. de la Constitución Española. En él se establece que "**Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sea reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social**". El compromiso de la intervención estatal queda limitado, aunque con un carácter muy amplio, con la obligación de la acción positiva de promover las condiciones o remover los obstáculos que dificultan la participación ciudadana. En este sentido, los Servicios Sociales van a constituir el instrumento esencial para la implantación de este modelo de política social. Y esto pese a que la C.E. únicamente hace referencia a éstos de manera muy sectorial en relación a la tercera edad (art. 50).
El principio de igualdad.	Este compromiso va a encontrar otro apoyo en el **artículo 14, "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".** El artículo recoge dos matices de la igualdad. Por una parte, su dimensión clásica y formalista desde la Revolución Francesa, la igualdad ante la ley, equiparando a los individuos ante el derecho, al margen de sus condiciones particulares. Por otra, la más moderna, la igualdad como **no discriminación por ninguna circunstancia concreta del individuo.** Esta segunda dimensión fundamental el principio de **igualdad compensatoria** que se encuentra explícitamente reforzado en casos concretos en la propia C.E. (arts. 49 y 50). Este significado del artículo 14 es el que fundamenta la intervención política y administrativa a favor de grupos en situación objetiva de desigualdad por cualquier causa. Las actuaciones, por ejemplo, en relación a los gitanos o a la mujer, constituyen muestras de la puesta en práctica de estas políticas compensatorias.

El progreso económico y social.	Ya en el mismo preámbulo de la Constitución se expresa el compromiso con un **orden económico y social justo,** que debe presidir toda la intervención del Estado. El **artículo 40.1.** especifica que **"Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa".**
Los compromisos internacionales.	Junto a los argumentos ya mencionados, podemos encontrarnos con una última idea. En el **artículo 10.2**. se afirma que "**las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificadas por España".** Se trata de resaltar el peso del contexto internacional, para definir las pautas en política social dentro de nuestro país. Existen numerosos textos internacionales, de organismos de los que forma parte España y ratificados por nuestro país, que se refieren a los Servicios Sociales. Y precisamente por estar ratificados se incorporan a nuestro ordenamiento interno.
Los principios rectores de la política económica y social.	En el capítulo 3 del Título I se desarrollan **los principios rectores de la política social y económica**. Es este el capítulo donde hubiera sido más adecuado referirse de forma concreta a los Servicios Sociales desde un tratamiento global, como un sistema público de protección social o de bienestar. Esta ausencia es importante, y de ella se han derivado problemas interpretativos y de distribución de competencias respecto a los Servicios Sociales. No obstante, la C.E., al enumerar los principios rectores de la política social y económica, hace referencia a diversos **grupos o sectores** (familia, emigrantes, discapacitados, mayores …) a los que concede relevancia específica, llevando su protección al texto constitucional. Junto a la mención de estos grupos concretos, que podíamos llamar sectores sobre los que actúan los Servicios Sociales Especializados, la C.E. formula compromisos en materia de política social de forma explícita (educación, seguridad social, vivienda, sanidad …). Algunos autores han señalado la diferencia que se plantea en la Constitución en las referencias que se plantean en determinados ámbitos de protección social –educación, por ejemplo- y la escasez de referencias en torno a la Asistencia Social. Hay que tener en cuenta que los ámbitos educativos, sanitarios, de vivienda, incluso de la Seguridad Social … contaban ya con una más o menos amplia tradición en nuestro país, en cambio, el sistema de Servicios Sociales era aún algo novedoso.
Competencias de las CC.AA.	El artículo 148 de la Constitución marca las competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas y, entre ellas, destacamos: • **Art. 148.1.20: asistencia social**

Ante la falta de concreción del texto constitucional podemos recurrir a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque señalando que son muy escasas las sentencias en las que se plantea algún contenido sobre la asistencia social.

En primer lugar, hay que citar la **STC 76/1.986, de 9 de junio.** Se afirmaba lo siguiente:

> *"La noción de asistencia social no está precisada en el texto constitucional, por lo que ha de entenderse remitida a conceptos elaborados, en el plano de la legislación general, que no han dejado de ser tenidos en cuenta por el constituyente; de la legislación vigente se deduce la* ***existencia de una asistencia social externa al sistema de Seguridad Social,*** *y no integrada en él, a la que ha de entenderse la remisión hecha en el artículo 148.1.20 de la Constitución (...). Esta asistencia social aparece como un mecanismo por grupos de población a los que no alcanza aquel sistema y que opera mediante técnicas distintas de las propias de la Seguridad Social. En el momento actual –con independencia de que la evolución del sistema de la Seguridad Social pueda ir en la misma dirección- es característica de la asistencia social su sostenimiento al margen de toda obligación contributiva o previa colaboración económica de los destinatarios o beneficiarios".*

El Tribunal Constitucional no entra en la definición de los contenidos de la asistencia social, pero va a hacer algunas precisiones importantes:

1. Es una actuación externa a la Seguridad Social, dirigida a colectivos no integrados en dicho sistema.
2. Se financia sin la previa colaboración económica de sus beneficiarios.

Es también muy interesante la afirmación que hace esta Sentencia acerca de la posible evolución del sistema de Seguridad Social hacia criterios no contributivos, como de hecho sucederá a partir de la aprobación de las Pensiones no Contributivas en el año 1.990.

La **STC 146/1.986, de 25 de noviembre** añade algunos elementos más relacionados con la práctica nacional e internacional. Esta Sentencia va a seguir las pautas de la Carta Social Europea, y define la asistencia social como

> "Una técnica de protección fuera del sistema de la Seguridad Social, con caracteres propios, que la separan de otras afines o próximas a ellas".

Este mismo planteamiento se retoma en la **STC 13/1.992, de 6 de febrero.** En ella se establece como nota distintiva de la asistencia social el hecho de *"ser dispensada por entes públicos"* y su carácter de *"técnica pública de protección que la distingue de la clásica beneficencia, en la que históricamente halla sus raíces".*

3.2.- LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La creación en España del **Sistema Público de Servicios Sociales** se orientaría desde los siguientes objetivos:

- El derecho social de los ciudadanos a las prestaciones sociales y, en consecuencia, la superación de los modelos de Beneficencia Pública, y su correspondiente transformación bajo la política del Bienestar Social en una **legislación específica** de constitución del Sistema Público de Servicios Sociales.
- La **definición de competencias** en materia de Servicios Sociales, en el marco del Estado de las Autonomías y la articulación de competencias entre Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

La articulación de las competencias de los distintos poderes públicos viene propuesta en la CE en un sistema de doble lista: el art. 149 recoge las competencias que en todo caso corresponden al Estado central, mientras que el **art. 148** relaciona las materias específicas que pueden ser asumidas por las comunidades autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Por lo tanto, un hecho que juega un papel determinante en la configuración de los actuales Servicios Sociales es la estructuración de España en **Comunidades Autónomas**. La configuración de las distintas Comunidades Autónomas y la asunción de competencias en materia de servicios sociales hicieron posible la promulgación de las primeras Leyes de Servicios Sociales. La paradoja es que este proceso se inicia coincidiendo con la **crisis económica**, cuyas consecuencias son el aumento de las necesidades socioasistenciales y la escasez de recursos para atenderlas.

En el caso del Estatuto de Autonomía, **Ley Orgánica 3/1.983, de 25 de febrero**, se asumen en este ámbito las siguientes competencias:

26.1.23. Promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

26.1.24. Protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud.

26.1.25. Promoción de la igualdad respecto a la mujer que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural.

3.3.- LAS LEYES DE SERVICIOS SOCIALES DE "PRIMERA GENERACIÓN".

Las lagunas y ambigüedades constitucionales podrían haber quedado resueltas con la aprobación de una Ley General de Servicios Sociales, ley que fue anunciada por diversos dirigentes políticos (incluso se presentó un borrador en el año 1.984), pero no llego a salir adelante dado que era una competencia exclusiva de las CC.AA.

En la práctica todas las CC.AA. han asumido la competencia en materia de asistencia social en sus respectivos Estatutos de Autonomía y han promulgado legislación específica para articular este sistema.

La **promulgación de las Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas**, en las que se definen las necesidades concretas a las que se quiere dar respuesta desde los Servicios Sociales, permitieron establecer un primer sistema integrado de Servicios Sociales, en el que los clásicos Servicios Sociales sectoriales (mayores, discapacitados ...) se sistematizan con la oferta de unas prestaciones homogéneas al conjunto de los sectores y una red de servicios que son la base del Sistema Público de Servicios Sociales.

Su objeto fue sido implantar en todas las comunidades un sistema público, que ponga a disposición de las personas y grupos en que éstas se integran recursos, acciones y prestaciones para el logro de su pleno desarrollo. Así como la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que producen la marginación.

Según estas leyes, los servicios sociales se encuentran estructurados en comunitarios y especializados.

- Los **comunitarios** constituyen la estructura básica del sistema público de servicios sociales, el primer nivel de atención y más próximo al usuario, siendo su finalidad el logro de unas mejores condiciones de vida mediante una atención integrada y polivalente. Se desarrollan en las zonas de trabajo social, entendidas como demarcaciones territoriales para una prestación eficaz de los mismos.
- Los **especializados** son aquellos que se dirigen hacia determinados sectores de población que por sus condiciones o circunstancias necesitan una atención específica.

En cuanto a la **financiación** de los servicios sociales, se hará con cargo a los **presupuestos públicos**: presupuestos generales del Estado, presupuestos de la Seguridad Social, presupuestos de las CC.AA. y presupuestos de las corporaciones locales. Además, está prevista la **colaboración de la iniciativa privada,** así como la **participación de los usuarios**.

La primera Ley de Servicios Sociales la aprueba el País Vasco en 1.982 (Ley 6/1.982, de 20 de mayo, la segunda fue Navarra -en 1.983 y la tercera, Madrid -en 1.984, la **Ley 11/1.984, de 6 de junio de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid**-. La última Ley de "primera generación" se aprobó en Cantabria en 1.992.

3.4.- EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES EN LA LEY 7/1.985.

La **promulgación en 1.985 de la Ley de Bases de Régimen Local**, donde se establecía la obligatoriedad de los Ayuntamientos a prestar Servicios Sociales supondrá la derogación jurídica de la Beneficencia Pública (aunque en la Comunidad de Madrid la Ley 11/1.984 derogo a la Ley de Beneficencia de 1.849).

Ni la Constitución ni los Estatutos de Autonomía fijaron las competencias de los entes locales en materia de servicios sociales. Por su proximidad a los problemas de los ciudadanos, los entes locales son el medio natural para la prestación de los servicios sociales. Tradicionalmente en España esto no había ocurrido así, tanto por la fuerte tendencia centralizadora, como por la escasez de recursos económicos de la Administración Local, aunque esta Administración fuera la primera receptora de las dificultades generadas para la ciudadanía en ámbitos como el empleo, la vivienda o la cobertura de las necesidades básicas.

Esta situación se modifica a partir de la transición política:

- Por el aumento de las demandas sociales de los ciudadanos a los entes locales, consecuencia del aumento de las demandas ciudadanas a la Administración Local que, además, fue la primera en ser democratizada.
- La Constitución establece el principio de descentralización, y en su artículo 140 especifica que "la Constitución garantiza la autonomía de los municipios, estos gozaran de personalidad jurídica plena, su gobierno y administración corresponde a los ayuntamientos".

En desarrollo a estos principios se aprobó la **Ley de Bases de Régimen Local** (2 de abril de 1985), que establece las competencias de los municipios (artículo 25), "el municipio para la gestión de sus intereses y e el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacerlas necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal".

La **Ley 7/1.985** permitió edificar un Sistema Público de Servicios Sociales en el que el **municipio**, como entidad local básica, asumía la **gestión directa de los Servicios Sociales.**

- El **artículo 25.2.k.** refería como competencia municipal la **prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social**.
- El **artículo 26.1.c.**, afirmaba que los municipios de más de 20.000 habitantes debían garantizar estos servicios, aunque permitiendo la solicitud de dispensa a la Comunidad Autónoma cuando su cumplimiento no les fuera posible [2].

3.5.- EL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES.

La **aprobación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales** surge como acuerdo de las Comunidades, los Municipios y la Administración Central para garantizar los derechos básicos, que, en Servicios Sociales, han de tener todos los ciudadanos españoles independientemente de su territorialidad.

Iniciado en **1.988** ha supuesto el desarrollo y la consolidación de la red básica de los servicios sociales de atención primaria desde la perspectiva metodológica y técnica de la concertación y la cooperación entre la Administración Central, Autonómica y Local. **La Comunidad de Madrid lo suscribió en el año 1.989.**

Son 15 las Comunidades Autónomas que suscriben el Plan Concertado, al que se suman en 1999 las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. (País Vasco y Navarra no lo suscriben).

A partir de este momento las administraciones iban a disponer de una organización y una estructura administrativa –especialmente las concejalías de Servicios Sociales de los Ayuntamientos- que iban a poner en marcha una amplia red de centros y equipos profesionales, promoviendo también la cooperación con organizaciones no gubernamentales para hacer efectiva la atención social.

---

[2] **IMPORTANTE: como veremos más adelante estos artículos han sido modificados, pero es importante citarles porque fueron fundamentales para poder desarrollar las redes de servicios sociales municipales.**

Estos Servicios Sociales se apoyan en un diseño novedoso de gestión, respecto a otros sistemas del Bienestar, ya que van a asumir la colaboración de la iniciativa privada y del voluntariado social, con lo cual se va a configurar un **Sistema Público de Gestión Mixta**, lo que implica gestión compartida, en determinados niveles de la prestación de servicios, bajo responsabilidad, control y seguimiento de las administraciones públicas que contratan o subvencionan los servicios de acuerdo a las cláusulas técnicas y administrativas establecidas. Tras la creación del Ministerio de Asuntos Sociales (1.988) éste realiza una propuesta a los gobiernos autonómicos ofreciéndoles un modelo unificado: el Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Entre las previstas ventajas del Plan Concertado se encontraban las siguientes:

- Servir de **guía o eje unificador en el desarrollo y proceso de implantación** del Sistema de Servicios Sociales.
- Cambiar viejas prácticas asistencialistas de un Estado benefactor, por **prestaciones de derecho de un Estado Social.**
- **Sistematizar y racionalizar necesidades, demandas y respuestas sociales** mediante la creación de un sistema público de protección social que contribuya al logro del bienestar social. Según este modelo este objetivo se lograría mediante la creación de una estructura- centros de servicios sociales, unidades de trabajo social- y de unos programas básicos que den respuesta a necesidades básicas.

El Plan Concertado propondrá cuatro **prestaciones básicas** (posteriormente cinco) que se garantizarán en todo el Estado español a través de las Administraciones Locales:

Información y orientación.	Esta prestación básica se define como un conjunto de medidas que facilitan al ciudadano, y a la comunidad en general, el conocimiento y acceso a los recursos sociales en una relación de ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos sociales, constituyendo a la vez un instrumento dinámico y eficaz para la planificación. Esta prestación tiene un doble objetivo básico: . Garantizar el acceso a los recursos básicos. . Proveer de datos para el mejor funcionamiento del Sistema en sus procesos de planificación, programación y evaluación.
Apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio.	Es una prestación básica de servicios sociales que presta una serie de atenciones o cuidados de carácter personal, psicosocial y educativo doméstico y técnico, a familias y personas con dificultades para procurarse su bienestar físico, social y psicológico, proporcionándoles la posibilidad de continuar en su entorno natural.
Alojamiento alternativo.	La prestación de Alojamiento Alternativo puede definirse como el conjunto de actuaciones que se realizan desde los servicios sociales para conseguir que el individuo en situación de necesidad cuente con un **marco estable para el desarrollo de la convivencia**. Los dos pilares fundamentales en los que se sustenta esta prestación lo constituyen la existencia de un alojamiento digno y una estructura básica de relación y convivencia. El objetivo fundamental será la incorporación del individuo a otras formas alternativas de convivencia familiar en los supuestos en que ésta sea inviable por no existir la unidad familiar o porque aun existiendo, presente una situación de deterioro psicológico, afectivo y /o socioeconómico que impida el desarrollo y el bienestar del individuo.

	Es un recurso válido y necesario para responder a **situaciones y/o estados de necesidad de alojamiento**, surgido de forma imprevista y al mismo tiempo como un dispositivo capaz de desarrollar programas que favorezcan la convivencia social.
Prevención e inserción social.	Supone la configuración de una serie de prestaciones específicas, programas o acciones instrumentales de tipología diversa dirigidas tanto a **individuos como a grupos específicos y a la comunidad** a la que pertenecen, para favorecer su propia **promoción** y las posibilidades de participación social, evitando los efectos de la marginación y la exclusión social y movilizando los recursos y estrategias necesarias para la **adquisición y desarrollo de habilidades psicosociales que permitan la inserción y adaptación social a dicha comunidad**.
Fomento de la solidaridad y cooperación social.	Se trata de potenciar las expresiones de **solidaridad** y de fomentar la **responsabilidad social de la comunidad** ante las situaciones de necesidad, haciendo partícipe a los ciudadanos de los problemas y soluciones de su entorno, procurando su identificación con los objetivos de la red básica de servicios sociales para lograr una mayor eficacia.

Para ello, mediante el Plan Concertado, se financiarán los siguientes **equipamientos**:

Centros de Servicios Sociales.	Es el equipamiento fundamental que establece el Plan. Tienen **carácter comunitario**, dotados de equipos técnicos, incluidas la Unidades de Trabajo Social, y de los medios necesarios que dan soporte a las Prestaciones Básicas, cuya función es la atención a la problemática social, tanto en un nivel individual y familiar como de desarrollo comunitario. En ellos se desarrollan los programas y servicios, dirigidos a toda la población, incluidos en el primer nivel de atención.
Centros de Acogida.	Son centros residenciales destinados a acoger, como medida de urgencia y transitoria a individuos, familias o grupos en dificultad social. Desarrollan funciones de orientación y valoración, prestando los medios necesarios para normalizar la convivencia social.
Albergues.	Son centros destinados a personas sin hogar o a transeúntes en situación de necesidad para prestarles alimentación y alojamiento durante un periodo de tiempo determinado, con servicios de información y asesoramiento tendentes a su inserción social.

Supone un instrumento fundamental, a través de la fórmula de **convenio administrativo**, de regular un conjunto de compromisos entre el Estado y las CC.AA. para reforzar el papel de las Corporaciones Locales en la prestación de servicios sociales. Estos **compromisos** son:

Compromiso de cofinanciación.	La Administración Central se compromete a destinar una consignación específica para el desarrollo del Plan Concertado en los Presupuesto Generales del Estado. El Consejo de Ministros aprueba los criterios de distribución, de previo acuerdo con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. Las Comunidades Autónomas se comprometen a aportar, para la financiación de los Proyectos, una cifra igual o superior a la que aporte el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En el caso de las Corporaciones Locales, titulares de los Proyectos su aportación estará determinada por la propia Comunidad Autónoma, atendiendo a las especiales circunstancias que en cada caso puedan concurrir.

Compromiso de gestión.	El Plan Concertado se fundamenta en la obligación de las Corporaciones Locales de prestar Servicios Sociales. Por ello establece que la titularidad de los equipamientos que contempla ha de ser, en todo caso, de la Corporación Local. Esta concertación se fundamenta y respeta las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Servicios Sociales, y de forma específica en su capacidad legislativa, de desarrollo normativo y de planificación.
Compromiso de información	Estos compromisos responden a la necesidad de conocer los resultados de la concertación, constatando su eficacia en lo que al cumplimiento de sus objetivos se refiere: Configurar una Red Pública Municipal de Servicios Sociales. Para cumplir este compromiso se diseñó una aplicación informática, el **Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)** que permitiera una recogida de información homogénea a nivel estatal. Estos datos son asimismo un elemento importante no sólo para la evaluación y una eficaz planificación de los servicios y equipamientos sino también para introducir medidas que pueden dar respuesta a nuevas necesidades emergentes.
Compromiso de asistencia técnica.	El Plan Concertado procura un espacio de intercambio de experiencias, con el objeto de ampliar los niveles de consenso en torno a las prestaciones básicas y equipamientos, para lograr su concreción y efectividad. Su fin es impulsar la colaboración entre las diferentes administraciones concertantes para alcanzar un desarrollo armónico de las prácticas de todas ellas, adaptándose a la diversidad que cada realidad exija.

En la actualidad el seguimiento del Plan Concertado se realiza desde el **Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia** (ubicado en el Ministerio que tenga competencias en materia de servicios sociales).

3.6.- DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES. LEYES DE SERVICIOS SOCIALES DE "SEGUNDA GENERACIÓN".

Entre los años 1.990 y 2.000 se produce una **consolidación de los Servicios Sociales**, pero ésta no supone una clarificación de la definición real del Sistema. Las estructuras de Servicios Sociales en su racionalización habían ido generando como contrapartida una burocratización y rigidez contradictorias con las exigencias de agilidad y flexibilidad que demandan las complejas situaciones sociales que deben abordar.

La aprobación de la **Ley 4/1.993**, de Servicios Sociales de Galicia, iba a marcar el inicio de las **Leyes de Servicios Sociales de "segunda generación**", que han ido asumiendo numerosas Comunidades Autónomas (Murcia, Aragón, Asturias, Madrid, Cantabria, Cataluña ...). Estas Leyes van a tratar de superar algunas de las deficiencias encontradas en las primeras Leyes. Entre estas mejoras podemos destacar:

- En las Leyes de primera generación se observa **un predominio de la concepción pública** de Servicios Sociales, en donde el sector privado sin ánimo de lucro ocupa u papel muy secundario y no había referencias a la iniciativa privada con ánimo de lucro. En las nuevas Leyes hay un claro **protagonismo del sector privado**, tanto de las organizaciones no lucrativas como de las del sector empresarial.
- En las Leyes de segunda generación se hace una referencia más explícita como fuente de financiación a las **aportaciones de los usuarios** para determinados servicios.
- Desde el punto de vista de la intervención social y de la población a la que se dirigen los Servicios Sociales se insiste en que son los **ámbitos locales y autonómicos** los más adecuados para la extensión y profundización de los derechos sociales.

- Igualmente se amplía la concepción de los Servicios Sociales a acciones articuladas en torno a las **personas, grupos y comunidades** sobre la base de **relaciones integradoras, solidarias y participativas.**

Para entender la evolución que ha seguido la legislación en Servicios Sociales es fundamental referirnos a las **corrientes modernizadoras** que se han desarrollado en las Administraciones y que han modificado sensiblemente los modelos de gestión de los Servicios Sociales. Estos enfoques se van a basar en los siguientes elementos:

- Una orientación de los servicios que buscan la satisfacción del **ciudadano-cliente**.
- La incorporación de fórmulas de gestión empresarial que contemplen **la participación de los empleados y de los ciudadanos en la gestión.**
- La **transparencia en las formas de actuación** a través de la incorporación de Cartas de Servicios, Contratos-Programa y evaluación de los usuarios de los servicios.
- La **externalización** con tutela por parte de la Administración de la gestión de los servicios, en busca de una mayor eficacia y ahorro.
- La **calidad de los servicios**, lo que implica la consulta continúa a los empleados, a los usuarios y a los ciudadanos.

En la Comunidad de Madrid, el **Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (2.001-2.003)** va a iniciar una nueva visión del sistema de Servicios Sociales, definida por cinco importantes elementos:

- Un **sistema universal de prestaciones sociales** –técnicas, económicas o en especie-, a las que tengan el derecho de acceder todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en condiciones **de igualdad, de responsabilidad y garantía pública**, en lo que se refiere a su ordenación, planificación, suficiencia financiera y garantías jurídicas.
- **Territorializado, cercano, accesible y próximo** al ciudadano y a su entorno de convivencia habitual.
- **Integrado, eficaz y eficiente**, de gestión ágil y burocracia reducida para dar respuesta de calidad a las necesidades de las personas.
- Que se anticipe a la demanda y se oriente a la **prevención de los problemas** sin esperar a que éstos se agraven.
- Que favorezca la **cooperación con la sociedad civil** para el cumplimiento de sus fines.

Para lograr este proceso el Plan Estratégico define seis líneas estratégicas. La primera de ellas se refiere al **Desarrollo de una Agenda Legislativa**, y como línea de acción fundamental se plantea la **elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales**, la **Ley 11/2.003, de 27 de marzo**, recientemente derogada.

3.7.- UN NUEVO MODELO: LEYES DE SERVICIOS SOCIALES DE "TERCERA GENERACIÓN".

A pesar de los avances experimentados por los sistemas de servicios sociales, desde finales del siglo pasado, en los ámbitos académicos, profesionales, gestores y asociativos se empezó a cuestionar determinados aspectos substantivos, especialmente los relacionados con la debilidad del derecho a los servicios sociales, el carácter universal, los derechos y deberes de los usuarios o la financiación como garantía de dichos derechos. Asimismo, se cuestionaron determinados asuntos organizativos, como la eficacia de la estructura funcional y territorial, la distribución de competencias entre las administraciones o el papel de las entidades privadas.

Todos estos debates propiciaron ciertos consensos en torno a la necesidad de **perfeccionar los servicios sociales** mediante el reconocimiento y la garantía de los derechos y la mejora de la eficiencia del sistema. Desde el año **2.006** se producirán modificaciones en los **Estatutos de Autonomía** de diversas Comunidades Autónomas (Valencia, Cataluña, Islas Baleares, Andalucía …), asegurando nuevas disposiciones relativas al derecho a los Servicios Sociales. Algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía otorgan expresamente competencias en materia de servicios sociales a los municipios, como es el caso de los Estatutos andaluz y catalán.

La innovación más importante ha sido la **inclusión de los derechos y deberes de las personas**. Estas reformas permitieron aprobar las llamadas **"Leyes de tercera generación**, la primera de ellas aprobada en **Navarra** el año 2.006.

Podemos identificar como los aspectos más significativos de estas Leyes:

- El **objetivo común** es garantizar el **derecho de acceso a los servicios sociales**, mediante la atribución del **derecho subjetivo** a todos o a algunos servicios y prestaciones y el establecimiento del **principio de universalidad**.
- Estas normas consolidan los **derechos y deberes** de los usuarios de los servicios y de los perceptores de las prestaciones. Se reiteran los derechos y libertades fundamentales, así como el derecho a la autonomía, a la toma de decisiones, al plan de atención individual y familiar o a los servicios de calidad. Se han ampliado y concretado los deberes a otros relacionados con la intervención social y la actitud proactiva o a la participación en los procesos de mejora, autonomía e inserción.
- La **calidad** se afirma con carácter obligatorio, tanto en el ámbito público como privado.
- Se mantiene el **sistema de servicios sociales público o de responsabilidad pública**, que actúa en forma de red y cuya gestión es mixta (público-privada), aunque con diversas intensidades.
- Se consolidan los **catálogos y carteras de Servicios Sociales**, regulándose los requisitos de acceso y la determinación de las características de las prestaciones y servicios.
- En numerosas Leyes se profundiza en la importancia de la **participación cívica**, mediante la apertura de nuevos espacios que faciliten la implicación de la ciudadanía en los servicios sociales, ya sea mediante los espacios representativos tradicionales o mediante nuevas modalidades de participación democrática en las deliberaciones y tomas de decisiones.
- Estas normas señalan la obligación de las administraciones públicas de aportar la **financiación y los recursos** para asegurar los derechos reconocidos, mediante las consignaciones presupuestarias necesarias.

La Comunidad de Madrid aprobó el pasado 21 de diciembre, la **Ley 12/2.022 de Servicios Sociales.**

3.8.- EL IMPACTO DE LAS LEYES SECTORIALES.

En el nuevo milenio se aprobarán un conjunto muy importante de Leyes a nivel estatal que supondrán un refuerzo importante al Sistema Público de Servicios Sociales.

- La **Ley Orgánica 4/2.000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España** establece que los extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y prestaciones sociales y los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tendrán derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.
- La **Ley 39/2.006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia** impacto con fuerza en los sistemas autonómicos de Servicios Sociales, introduciendo por primera vez en los servicios sociales el "derecho subjetivo" de acceso a los servicios y prestaciones garantizadas.

Igualmente, también darán un papel sustantivo al Sistema Público de Servicios Sociales las Leyes que se aprobarán en materia de protección de menores, en la responsabilidad penal de los menores infractores o en la lucha contra la violencia de género.

3.9.- LOS CAMBIOS EN LA LEY 7/1.985.

La Ley 7/1.985, desde su aprobación, ha sufrido más de veinte modificaciones, algunas especialmente significativas como la que permitió la regulación de los municipios de gran población. En diciembre de 2.013, las Cortes aprobaron la **Ley 27/2.013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local**.

En su Preámbulo se hace referencia a la obligación de cumplir el principio de estabilidad presupuestaria –consagrado con la modificación del artículo 135 de la Constitución, lo cual exige cambios a la Administración Local para que evite duplicidades con otras Administraciones y asegure los principios de sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos.

Así, desde estas premisas, se ha modificado el citado artículo 25, y en su nueva redacción, en el **artículo 25.2.e.** se limitan las competencias municipales a la **evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social**. Nos encontramos con un artículo muy ambiguo y confuso, en el que la intervención municipal prestacional -como se recogía en la Ley antes de esta modificación- parece quedar sustituida por la simple identificación y atención inmediata a las situaciones de necesidad asistencial.

En su **artículo 27.3.** se establece que la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas podrán delegar en los Municipios, garantizando el ahorro de recursos, diversas competencias, entre ellas, la **prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer** (art. 27.3.c.).

En su **disposición transitoria segunda** se establece que, a fecha de 31 de diciembre de 2.015, las Comunidades Autónomas deberán asumir la titularidad de las competencias propias de los municipios en materia de servicios sociales.

Durante los años 2.016 y 2.017 se presentaron y aprobaron numerosos recursos de inconstitucionalidad a diversos preceptos de esta Ley.

3.10.- EL CATÁLOGO DE REFERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó en el año **2.013** el **Catálogo de Referencia de Servicios Sociales.**

Este documento responde a la necesidad de alcanzar una definición de un Catálogo de Referencia, que incluya unos criterios comunes de calidad y de buen uso —solidario y responsable— de los servicios. Ello permitirá, por una parte, tener unos servicios sociales no sólo de **calidad**, sino también **sostenibles**, lo cual es un objetivo de todas las Administraciones Públicas; por otra, configurar el Sistema de Servicios Sociales como un elemento fundamental de cohesión social y apoyo a las personas; finalmente, sirve de marco de referencia para todas las Entidades que forman parte del Sistema de Servicios Sociales de nuestro país.

Este Catálogo, que recoge, identifica y define las prestaciones de referencia del Sistema Público de Servicios Sociales, parte del concepto de "Sistema público de servicios sociales" como un **conjunto de servicios y prestaciones que insertándose con otros elementos de protección social, tiene como finalidad la promoción y el desarrollo pleno de todas las personas y grupos dentro de la sociedad para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida, en el entorno de la convivencia, y la prevención y la eliminación de las causas que conducen a la exclusión social.**

La tipología de prestaciones se ha clasificado distinguiendo entre:

1.- Prestaciones de servicios	Entendiendo por tales las actuaciones que realizan los equipos técnicos orientadas a atender las necesidades sociales y favorecer la inserción social de los ciudadanos y ciudadanas, familias y grupos de población. Estas prestaciones que se pueden desarrollar desde equipamientos, programas, servicios, unidades administrativas y equipos multiprofesionales, entre otros, se agrupan en siete ejes temáticos que responden a su vez a diversas situaciones de necesidad social.
2.- Prestaciones económicas	Aportaciones económicas, de carácter periódico o pago único, ofertadas para garantizar mínimos de subsistencia o situaciones de emergencia sobrevenidas a los ciudadanos/as.

Y se diferencian entre:

Prestaciones de servicios	1.- Información, orientación, asesoramiento, diagnóstico y valoración. 2.- Autonomía personal, atención en el domicilio y respiro familiar. 3.- Intervención y apoyo familiar. 4.- Intervención y protección de menores. 5.- Atención residencial. 6.- Prevención e inclusión social. 7.- Protección jurídica.
Prestaciones económicas	1.- Renta mínima de inserción. 2.- Ayuda para víctimas de violencia de género. 3.- Prestaciones económicas para personas en situación de dependencia. 4.- Otras prestaciones económicas.

3.- ¿HACIA UNA LEY ESTATAL DE SERVICIOS SOCIALES?

El pasado 24 de enero de 2.023, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2.030 inició el proceso de tramitación -con la publicación de su Anteproyecto- de la **Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales.** Desde este Ministerio se publicó un documento de "consulta previa" en relación a este Anteproyecto de Ley.

3.1.- ANTECEDENTES DE LA NORMA.

Los Servicios Sociales son objeto de regulación por parte de las Comunidades Autónomas, al amparo del artículo 148.1.20ª de la Constitución Española que establece que éstas podrán asumir competencias en materia de "asistencia social". Bajo este precepto todas las comunidades autónomas asumieron en sus respectivos estatutos de autonomía la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, competencia reiterada en las más recientes reformas estatutarias. Y, en consecuencia, han aprobado sus propias leyes y las

ciudades de Ceuta y Melilla sus reglamentos, en el ámbito de servicios sociales en los cuales se definen sus principios inspiradores, prestaciones y servicios.

No obstante, y de cara a abordar el contenido para una ley de servicios sociales, se debe tener en cuenta que **desde el ámbito estatal ya se han venido regulando aspectos concretos que inciden sustancialmente en la regulación autonómica**, fijando **un mínimo común denominador** en ámbitos tales como la **protección a la infancia** (Ley Orgánica de protección jurídica del menor 1/1996 o Ley de Adopción internacional 54/2007 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), la **discapacidad** (Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos), la **dependencia** (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), la **violencia de género** (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género), las **pensiones no contributivas** (RD Ley 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social) o un **ingreso mínimo** (Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital), entre otras.

En cualquier caso, este proyecto legislativo refuerza y vertebra nuestro sistema de protección social, asegurando un modelo de gobernanza que en ningún caso va en detrimento del ejercicio de la competencia exclusiva por parte de las comunidades autónomas.

3.2.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDE SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA.

En la actualidad, existe una gran **pluralidad en la organización de los servicios sociales** en cada territorio. Mientras que esa diversidad permite adaptarse a las necesidades locales, también genera diferencias en la oferta de servicios que puede esperar la ciudadanía.

La creación de un marco legal estatal para los servicios sociales permitiría **garantizar una protección mínima en el conjunto del territorio español**, avanzar hacia unos **servicios sociales universales**, consagrando el **derecho subjetivo de la ciudadanía** a contar con esa cobertura y protección, y facilitar la **cooperación entre los distintos niveles de gobierno**.

Además, permitiría avanzar en la **mejora de la calidad de los servicios sociales**, definiendo su alcance, replanteando **requisitos mínimos comunes y los estándares de información**, reforzando la rendición de cuentas y promoviendo su modernización para abordar las necesidades de la ciudadanía.

3.3.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

El Estado -junto a los demás Poderes Públicos- tiene el mandato de **promover la igualdad sustancial del individuo y de los grupos** en que se integra (art. 9.2 de la C.E), reafirmando la igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento (art. 1.1 C.E.). Asimismo, el art. 139. 1 CE establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y el **art. 149.1.1** CE consagra su competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Ambos preceptos se erigen como principios constitucionales garantes de las condiciones de igualdad en el acceso a los derechos y asunción de obligaciones por parte de todas las personas en cualquier parte del territorio del Estado.

De la obligación que tiene el Estado **de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos sociales**, se extrae la necesidad de que se establezca una regulación básica tanto del alcance, la intensidad como de la compatibilidad de servicios y prestaciones sociales. De esta forma se consigue que, más allá de la legítima diversidad territorial de las regulaciones, la ciudadanía pueda disfrutar en igualdad de los derechos que el ordenamiento constitucional les asegura.

La ratificación por España el pasado 29 de abril de 2021 de la **Carta Social Europea (revisada),** hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996 (BOE de 11 de junio de 2021), establece entre otros el derecho a los beneficios de los servicios sociales (artículo 14) y el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social (artículo 30). Esto supone el compromiso por parte del Estado a:

- Garantizar el efectivo ejercicio de ambos derechos mediante el fomento y organización de servicios sociales que contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, así como a su adaptación al medio o entorno social.
- Estimular la participación de los individuos y de las entidades sociales o de otra naturaleza en la creación y mantenimiento de tales servicios.
- Adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para promover el acceso efectivo de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus familias.

3.4.- OBJETIVOS DE LA NORMA.

La futura Ley tiene por objeto **regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales, con la colaboración y participación de todas las Administraciones públicas y la garantía de un contenido mínimo común de derechos en cualquier parte del territorio del Estado español**.

Las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales tienen los siguientes **objetivos esenciales:**

1. Mejorar la calidad de vida y promover la normalización, la participación y la inclusión social, económica, laboral, cultural y educativa y de salud de todas las personas.

2. Fomentar la cohesión social y la solidaridad

3. Promover la autonomía personal y familiar y prevenir y detectar las situaciones de necesidad social de la población, así como planificar y desarrollar estrategias de actuación, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia y situaciones de riesgo y/ o exclusión.

4. Favorecer la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, de discapacidad, de edad, de origen o por cualquier otra razón o circunstancia personal o social, e impulsando políticas de inclusión social.

Bibliografía

. ALEMAN BRACHO, Carmen; "La política de asistencia social desde la transición democrática". Revista de Estudios Políticos. Nº 87. Enero-marzo 1.995.

https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/46834

Un artículo de una autora clásica que nos acompaña por la primera parte de este tema: el período que va desde la transición política -con la democratización de las instituciones- a los primeros pasos para la configuración del sistema público de servicios sociales. Analiza el papel de la Constitución y la distribución de las competencias con la aprobación de las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales. Se trata, de alguna manera, de un documento que es "testigo histórico" de todo este proceso.

. ARIAS MARTÍNEZ, María Antonia; "Las competencias locales en materia de Servicios Sociales tras la aprobación de la Ley 27/2.013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local". Revista de Administración Pública, nº 194. Madrid, mayo-agosto de 2.014.

https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/37044mariaantoniaariasmartinezrap194.pdf

La proximidad de las Administración municipal a la ciudadanía es un elemento fundamental para entender la configuración del sistema español de servicios sociales. Las modificaciones introducidas por la Ley 27/2.013 (que realmente no han llegado a aplicarse) suponían un riesgo muy significativo de reduccionismo y restricciones de las competencias locales en cuanto a los contenidos prestacionales de los servicios sociales.

. TORNOS MAS, Joaquín y GALÁN GALÁN, Alfredo; "La configuración de los Servicios Sociales como Servicio Público. Derecho subjetivo de los ciudadanos a la prestación del servicio". Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social). Enero de 2.007.

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/bd843947-38e2-4265-bbe8-a5793483527 3/132.+La+configuracion+de+los+servicios+sociales+como+servicio+publico.+derecho+subjetivo+de+los+ciudadanos+a+la+prestacion+del+servicio%28Castellano%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

En este documento se analizan las consecuencias que se derivan de la afirmación según la cual los servicios sociales son servicios públicos. Tras un análisis detallado de ambos conceptos –"servicios sociales" y "servicio público"- reflexiona sobre la incapacidad del actual marco normativo para configurar las prestaciones de servicios sociales como verdaderos derechos subjetivos.

. GÓMEZ ISA, Felipe; Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Hacia un nuevo contrato social intra e inter-generacional". Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público. Volumen 70/2. Julio-Diciembre 2.022.

https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/2650/3128

La primera parte del artículo desarrolla un análisis muy interesante sobre los ODS de Naciones Unidas, repasando el proceso histórico previo y sus contenidos fundamentales, tras el fracaso de otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos. Destaca la radical novedad de la incorporación del concepto "sostenible" en este ámbito. En la segunda parte del artículo -quizá menos interesante para la preparación- analiza con más detalle algunos de los objetivos.

. OCDE; "Modernización de los servicios sociales en España. Diseño de un nuevo marco estatal". 2.022.

https://www.oecd.org/health/Modernizacion-de-los-servicios-sociales-en-Espana.pdf

En este informe se examina la situación actual de la prestación de los servicios sociales en España, analizando su marco competencial desde un punto de vista legal, proponiendo orientaciones para adaptar este sistema a la evolución de las necesidades sociales. Se presta especial atención a la creación de un nuevo marco jurídico -de ámbito estatal- que garantice los servicios sociales como derechos consolidados, reduciendo las deficiencias de los servicios y mejorando su calidad.

. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2.030; "Anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales". 24 de enero de 2.023.

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/servicio-a-la-ciudadania/proyectos-normativos/documentos/AP-SERVICIOS-SOCIALES.pdf

Es el anteproyecto de Ley en toda su extensión. El articulado no merece la pena leerlo hasta que no se haya avanzado en su proceso parlamentario, en cambio sí son interesantes las 6 primeras páginas, la exposición de motivos, donde se justifica la necesidad de la nueva Ley.

. VILA, Antonio; "La nueva generación de leyes autonómicas de Servicios Sociales (2.006-2.011): análisis comparativo". Azarbe. Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, nº 1. 2.012.

https://revistas.um.es/azarbe/article/view/151201/137451

En este artículo se analizan diez leyes autonómicas de servicios sociales promulgadas durante el período 2.006-2.011 (no se hace referencia a la de la Comunidad de Madrid, ya que no corresponde a este período). Analiza cuáles son las aportaciones que realizan, especialmente en el ámbito del reconocimiento y garantía de los derechos, relativos al acceso a los servicios y prestaciones y a los derechos y deberes que corresponden a los destinatarios.

. PELEGRÍ Viaña, Xavier; "El modelo de servicios sociales en España". Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XVII, nº 2, 2.007.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65417206

Analiza la realidad de los servicios sociales en España, un proceso que se inicia con mucho retraso en comparación con otros países. Plantea que en treinta años se ha conseguido forjar un amplio conjunto articulado de dispositivos de protección social que no existían antes de la Constitución.

. Análisis y debate sobre los servicios sociales en la Ciudad de Madrid (Jornada de 16 de mayo de 2.018). "Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid: ¿qué modelo necesitamos para el futuro?".

https://www.fresnoconsulting.es/upload/77/87/fresno_Modelo_SerSoc_draft_final__2jul2018_.pdf

La introducción de este tema está recogida de este documento. Es un documento muy interesante, muy crítico (a pesar de ser de una administración) y que genera numerosas reflexiones sobre que modelo de servicios sociales queremos desarrollar. Es uno de los documentos preparatorios del nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.